Приложение № ___
к Приказу Министра
здравоохранения
Республики Узбекистан
№____ от «____» _____2025 г.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР КАРДИОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ «ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА»

ТАШКЕНТ – 2025

"УТВЕРЖДАЮ"
Министр здравоохранения
Республики Узбекистан
А.А. Худаяров
_____
«____»_____2025 г .

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ «ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА»

ТАШКЕНТ – 2025

"СОГЛАСОВАНО"
Директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии
Х.Г. Фозилов

_____ _____ 2025 год

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ «ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА»

ТАШКЕНТ 2025

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ

ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

Кодирование по МКБ 10:	**Название нозологии:**	**Специалисты, привлекаемые по нозологии для диагностики и лечения в амбулаторных условиях**		**Специалисты, привлекаемые по нозологии для диагностики и лечения в стационарных условиях**	
		Основные курирующие специалисты	Дополнительные курирующие специалисты	Основные курирующие специалисты	Дополнительные курирующие специалисты
I20.8	Стенокардия напряжения I-IV ФК	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист
I25.0	Атеросклеротическая сердечно-сосудистая болезнь, так описанная	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист
I25.1	Атеросклеротическая болезнь сердца	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист
I25.2	Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда Син.: Постинфарктный кардиосклероз	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог,	Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог,

			эндокринолог, нефролог, окулист		эндокринолог, нефролог, окулист
I25.6	Бессимптомная ишемия миокарда	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист
I25.8	Другие формы хронической ишемической болезни сердца	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист
I25.9	Хроническая ишемическая болезнь сердца неуточненная	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист

Кодирование по МКБ 11:	**Название нозологии:**	**Специалисты, привлекаемые по нозологии для диагностики и лечения в амбулаторных условиях**		**Специалисты, привлекаемые по нозологии для диагностики и лечения в стационарных условиях**	
		Основные курирующие специалисты	Дополнительные курирующие специалисты	Основные курирующие специалисты	Дополнительные курирующие специалисты
BA40.1	Стенокардия напряжения I-IV ФК	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог,	Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог,

			реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист		реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист
BA50 — BA6Z	Хроническая ишемическая болезнь сердца	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист
BA52	Атеросклероз коронарных артерий	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист
BA52.0	Атеросклероз нативной коронарной артерии	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист
BA52.1	Атеросклероз аутологичного коронарного шунта	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист
BA52.10	Атеросклероз аутологичного артериального коронарного шунта	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог,	Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог,

			эндокринолог, нефролог, окулист		эндокринолог, нефролог, окулист
BA52.11	Атеросклероз аутологичного венозного коронарного шунта	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист
BA52.1Z	Атеросклероз неуточненного аутологичного коронарного шунта	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист
BA52.2	Атеросклероз неаутологичного коронарного шунта	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист
BA52.Z	Атеросклероз коронарных артерий, неуточненной локализации	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист
BA50	Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист

BA81	Аневризма коронарной артерии	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист
BA81.0	Аневризма коронарной артерии с перфорацией	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист
BA81.1	Аневризма коронарной артерии с разрывом	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист
BA81.2	Аневризма коронарной артерии без упоминания о перфорации или разрыве	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист
BA82	Диссекция коронарной артерии	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист
BA83	Приобретенная фистула коронарной артерии	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Интервенционный кардиолог,	Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог	Интервенционный кардиолог,

			кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист		кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист
BA5Y	Другая уточненная хроническая ишемическая болезнь сердца	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист
BA5Z	Хроническая ишемическая болезнь сердца, неуточненная	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист
BA84	Хроническая полная окклюзия коронарной артерии	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Интервенционный кардиолог/реаниматолог	Интервенционный кардиолог, кардиохирург, невропатолог, реаниматолог, эндокринолог, нефролог, окулист

*** при заполнении стандарта обязательно указывают нозологию, ее течение у взрослых, беременных, детей и пожилых людей, а также период заболевания.**

Также не рекомендуется заполнять таблицы, не соответствующие данной нозологии. (Например, если по нозологии не ведется хирургическая практика, не заполняется таблица «ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ», или если в нозологию не входит паллиативное лечение - не заполняется таблица (ПАЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ).

ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ, РЕАБИЛИТАЦИЯ и ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Диагностические мероприятия	Название медицинской услуги	Уровень и вид медицинской помощи					Минимальное количество услуг и исследований	Срок лечения
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь				
		СВП/СП	МПЦП	Районная (городская) больница	ЛПУ на уровне области	ЛПУ на уровне республики		
Консультации основных специалистов (врачей)	1. Семейный врач	+					- для I-II ФК: 2 раза в год;	Амбулаторное наблюдение пожизненное; Стационарное лечение: 5-10 дней*
	2. Кардиолог		+	+	+	+	- для III-IV ФК 4 раза в год	
	3. Терапевт		+	+			- для I-II ФС и других форм ХИБС: 2 раза в год	
Примечание: * Продолжительность стационарного лечения зависит от цели госпитализации. Осмотры специалистов в стационарных условиях проводятся ежедневно.								
Консультации дополнительных специалистов (врачей	1. Интервенционный кардиолог			+	+	+	для III-IV ФК 1 раз в год	
	2. Кардиохирург				+	+	для III-IV ФК 1 раз в год	
	3. Интервенционный аритмолог					+	По показаниям	
	4. Невропатолог		+	+	+	+	По показаниям	
	5. Эндокринолог		+	+	+	+	По показаниям	
	6. Нефролог		+	+	+	+	По показаниям	
	7. Окулист		+	+	+	+	По показаниям	
Примечание: Все осмотры узких специалистов организовываются по показаниям. В стационарных условиях количество осмотров узких специалистов следует проводить в соответствии с клинической ситуацией.								
Основные лабораторные исследования	1. Общий анализ крови	+	+	+	+	+	- для I-II ФС и других форм ХИБС: 2 раза в год - для III-IV ФК 4 раза в год	
	2. Общий анализ мочи	+	+	+	+	+		
	3. Креатинин	+	+	+	+	+		
	4. АЛТ, АСТ, билирубин	+	+	+	+	+		
	5. Сахар крови	+	+	+	+	+		
	6. Общий холестерин	+	+	+	+	+		

	7. Триглицериды		+	+	+	+		
	8. Хс-ЛПВП		+	+	+	+		
	9. Хс-ЛПНП		+	+	+	+		
	10. Общая КФК		+	+	+	+		
	11. Коагулограмма	+	+	+	+	+		
Примечание: если материально-техническая база СВП/СП позволяет оценить общую КФК с полным липидным спектром, то ВОП должен проводить эти исследования. **Количество лабораторных исследований в стационарных условиях определяется исходя из клинического состояния.**								
Дополнительные лабораторные исследования	1. Тропонин		+	+	+	+	**По показаниям**	
	2. МВ-КФК			+	+	+		
	3. RW			+	+	+		
	4. Группа крови			+	+	+		
	5. Гепатит В и С			+	+	+		
	6. ВИЧ			+	+	+		
	7. МНУП		+	+	+	+		
	8. ТТГ		+	+	+	+		
	9. Гликированный гемоглобин		+	+	+	+		
	10. Электролиты		+	+	+	+		
	11. Общий белок		+	+	+	+		
	12. Гомоцистеин		+	+	+	+		
Примечание: Группа крови, гепатиты В и С, тесты на ВИЧ должны быть выполнены пациентам, которым запланирована реваскуляризация миокарда (ЧКВ или АКШ). **Количество лабораторных исследований в стационарных условиях определяется исходя из клинического состояния.**								
Основные инструментальные исследования	1. ЭКГ	+	+	+	+	+	**- для I-II ФС: 2 раза в год - для III-IV ФК 4 раза в год**	
Примечание: В стационарных условиях количество ЭКГ определяют исходя из клинического состояния.								
Дополнительные инструментальные исследования	1. ЭхоКГ		+	+	+	+	**По показаниям**	
	2. ВЭМ или Тредмил		+	+	+	+		
	3. Рентгенография груднок клетки		+	+	+	+		
	4. Коронарный				+	+		

	кальций							
	5. УЗИ сонных артерий		+	+	+	+		
	6. ЭКГ мониторирование по Холтеру				+	+		
	7. Стресс-ЭхоКГ				+	+		
	8. МСКТ-коронарография					+		
	9. Инвазивная коронарография				+	+		
	10. ОФЭКТ/ПЭТ					+		
	11. Фракционный резерв кровотока (FFR), ВСУЗИ					+		
	12. ЭГДФС		+	+	+	+		
	13. УЗИ внутренних органов		+	+	+	+		

Примечание: Исследование коронарного кальция и УЗИ сонной артерии могут проводиться на всех уровнях ЛПУ в качестве скрининговых исследований ИБС.

Количество инструментальных исследований в стационарных условиях определяется исходя из клинического состояния.

ЭГДФС следует проводить перед реваскуляризацией миокарда (ЧКВ или АКШ) или у пациентов с повышенным риском желудочно-кишечных кровотечений, получающих антиагреганты.

Диагностические мероприятия	Название медицинской услуги	Уровень и вид медицинской помощи					Минимальное количество услуг и исследований	Срок лечения
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь				
		СВП/СП	МПЦП	Районная (городская) больница	ЛПУ на уровне области	ЛПУ на уровне республики		
Другого типа исследования	1. Предтестовая вероятность	+	+	+	+	+	Во время первого осмотра	
	2. Шкала SCORE2	+	+	+	+	+	Используется во время скрининга ХИБС	
	3. Шкалы CHA2DS2-VASc и HAS-BLED	+	+	+	+	+	При каждом осмотре	

	4. SYNTAX score			+	+	+	Используется для определения типа реваскуляризации миокарда после получения результатов КАГ	

Примечание: Предтестовая вероятность должна быть оценена у всех пациентов до исследований.
Шкала SCORE2 позволяет оценить сердечно-сосудистый риск и рекомендуется при скрининге ИБС.
Шкала CHA2DS2-VASc рекомендуется использовать при оценки риска инсульта у пацитов с ИБС и ФП.
Шкала HAS-BLED рекомендуется для оценки риска кровотечений при применении пероральных антикоагулянтов у больных ИБС и ФП.

(МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ)

Терапевтические мероприятия (основное медикаментозное лечение)		Уровень и вид ПЛАНОВОЙ медицинской помощи					Средняя суточная доза	Курсовая доза
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь				
Название (международное непатентованное) лекарственного средства	Применение и дозировка лекарственного средства	СВП/СП	МПЦП	Районная (городская) больница	ЛПУ на уровне области	ЛПУ на уровне республики		
1. Ацетилсалициловая кислота	75-150 мг 1 раз в день	+	+	+	+	+	75-150 мг	пожизненно
2. Статины: - Розувастатин - Аторвастатин	- Розувастатин 5-40 мг 1 раз в день - Аторвастатин 10-80 мг 1 раз в день	+	+	+	+	+	- Розувастатин 5-40 мг - Аторвастатин 10-80 мг	пожизненно
3. Блокаторы РААС: А) иАПФ: - Эналаприл - Рамиприл - Периндоприл Б) БРА (сартанлар): - Валсартан - Лозартан - Кандесартан	иАПФ: - Эналаприл 2,5-20 мг 2 раз в день - Рамиприл 2,5-10 мг 1 раз в день - Периндоприл эрбумин 2-8 мг 1 раз в день - Периндопил	+	+	+	+	+	иАПФ: - Эналаприл 2,5-20 мг - Рамиприл 2,5-10 мг - Периндоприл эрбумин 2-8 мг - Периндопил аргинин 2,5-10	пожизненно

- Телмисартан - Азилсартан - Олмесартан	**аргинин 2,5-10 мг 1 раз в день БРА: - Валсартан – 40-320 мг 2 раз в день - Лозартан 25-100 мг 1 раз в деь - Кандесартан 4-32 мг 1 раз в день - Телмисартан 10-80 мг 1 раз в день - Азилсартан 20-80 мг 1 раз в день - Олмесартан 10-40 мг 1 раз в день**						**мг БРА: - Валсартан – 40-320 мг - Лозартан 25-100 мг - Кандесартан 4-32 мг - Телмисартан 10-80 мг - Азилсартан 20-80 мг - Олмесартан 10-40 мг**	
4. Коротко действующие нитраты: - Нитроглицерин	**Нитроглицерин 0,1-1,2 мг использовать в виде таблеток или спрея сублингвально только при приступах стенокардии**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**0,1-1,2 мг**	**-**
5. Бета-блокаторы: - Бисопролол - Метопролол - Небивалол - Карведилол	**- Бисопролол 2,5-10 мг 1 раз в день - Метопролол сукцинат 25-100 мг 1 раз в день - Небивалол 2,5-10 мг 1 раз в день - Карведилол 3,125-25 мг кунлик дозаси 2-3 раза в день**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**- Бисопролол 2,5-10 мг - Метопролол сукцинат 25-100 мг - Небивалол 2,5-10 мг - Карведилол 3,125-25 мг**	**пожизненно**
6. Дегидропиридиновые	**- Амлодипин 2,5-**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**- Амлодипин**	**пожизнено**

блокаторы кальциевых каналов: - Амлодипин - Лерканидипин - длительно действующий нифедипин	10 мг 1 раз в день - Лерканидипин 5-20 мг 1 раз в день - Нифедипин ретард 30-60 мг 1 раз в день						2,5-10 мг - Лерканидипин 5-20 мг - Нифедипин ретард 30-60 мг	
Примечание: при ИБС блокаторы РААС назначаются при наличии АГ, ХСН, СД								

Терапевтические мероприяти (дополнительное медикаментозное лечение)		Уровень и вид медицинской помощи					Средняя суточная доза	Курсовая доза
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь				
Название (международное непатентованное) лекарственного средства	Применение и дозировка лекарственного средства	СВП/СП	МПЦП	Районная (городская) больница	ЛПУ на уровне области	ЛПУ на уровне республики		
1. Клопидогрел	75 мг 1 раз в день	+	+	+	+	+	75 мг	1 год*
2. Тикагрелор	90 мг 2 раза в день		+	+	+	+	180 мг	1 год
3. Прасугрел	5-10 мг 1 раз в день		+	+	+	+	5-10 мг	1 год
4. Ривароксабан	2,5 мг 2 раза в день		+	+	+	+	5 мг	пожизненно**
5. Апиксабан	2,5-5 мг 2 раза в день		+	+	+	+	5-10 мг	1 год
6. Эзетимиб	10 мг 1 раз в день		+	+	+	+	10 мг	пожизненно
7. Инклисиран	284 мг 1 раз в 6 месяцев		+	+	+	+	568 мг йиллик дозаси	пожизненно
8. Фенофибрат	145 мг 1 раз в день		+	+	+	+	145 мг	пожизненно
9. Омега 3	1 г по 2 капсулы 2 раза в день		+	+	+	+	4 г	пожизненно
10. Ивабрадин	5-7,5 мг 2 раза в день		+	+	+	+	10-15 мг	пожизненно
11. Длительно действующие нитрати: - Изосорбида динитрат - Изосорбида мононитрат	- Изосорбида динитрат: Аерозоль используется	+	+	+	+	+	60-120 мг	пожизненно

	только при приступах стенокардии 1-3 раза в день под язык; таблетки - 20 мг 2-3 раза (или 2 раза в день по 40 мг или 1-2 раза в день по 60 мг); капсулы 120 мг 1 раза в день. - Изосорбида мононитрат: 20-40 мг 2-3 раза в день							
13. Недигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов: - Верапамил - Дилтиазем	**- Верапамил: 40-80 мг 3-4 раза в день. Максимальная суточная доза до 480 мг. - Дилтиазем: 60 мг 3 раза в день или 90 мг 2 раза в день. Максимальная суточная доза до 360 мг.**		**+**	**+**	**+**	**+**	**Верапамил: 160-320 мг Дилтиазем: 180 мг**	**пожизненно**
13. Триметазидин	**80 мг 1 раза в день, 35 мг 2 раза в день**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**70-80 мг**	**пожизненно**
14. Ранолазин	**500-1000 мг 2 раза в день**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**1000-2000 мг**	**пожизненно**

Примечание: Эзетимиб и Инклизиран считаются препаратами 2-й и 3-й линии гиполипидемической терапии и добавляются при неэффективности статинов.

Фенофибрат и Омега-3 применяют при сочетании гиперхолестеринемии с гипертриглицеридемией.

Верапамил или Дилтиазем рекомендуются в случаях, когда применение бета-адреноблокаторов противопоказано (бронхиальная астма, аллергические реакции и др.).

*** Продолжительность применения клопидогрела составляет 1 год у пациентов, перенесших ОКС, ЧКВ или АКШ. Может назначаться длительно с ацетилсалициловой кислотой, если у пациента с ИБС имеется высокий сердечно-сосудистый риск.**

**** Ривароксабан по 2,5 мг 2 раза в день следует применять длительно с ацетилсалициловой кислотой при многососудистом поражении коронарного бассейна. Если у пациента с ИБС имеется ФП, ривароксабан назначают по 15–20 мг в сутки.**

(ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

Лечебные мероприятия (оперативное лечение)	Уровень и вид ПЛАНОВОЙ медицинской помощи				
	Амбулаторная помощь		Стационарная помощь		
Название оперативного (ой) вмешательства/процедуры/манипуляции	СВП/СП	МПЦП	Районная (городская) больница	ЛПУ на уровне области	ЛПУ на уровне республики
1. Чрескожное коронарное вмешательство			+	+	+
2. АКШ				+	+
3. Усиленная наружная контрпульсация				+	+

Примечание: ЧКВ рекомендуется, если в коронарном бассейне имеется 1- ил 2-сосудистое (значение шкалы SYNTAX ниже 32 баллов) и оптимальная медикаментозная терапия недостачно эффективна

АКШ рекомендуется при 3- и многососудистом поражении в коронарном бассейне (значение шкалы SYNTAX выше 32 баллов), либо при поражении ствола левой коронарной артерии и/или наличии СД.

Усиленная наружная контпульсация: рекомендовано 35 сеансов для улучшения коронарного кровотока у больных с рефрактерной стенокардией.

(ЛЕЧЕБНЫЙ СТОЛ И ДИЕТА)

Режим питания	Уровень и вид медицинской помощи				
	Амбулаторная помощь		Стационарная помощь		
Диетический стол и его продолжительность	СВП/СП	МПЦП	Районная (городская) больница	ЛПУ на уровне области	ЛПУ на уровне республики
1. Стол №10, пожизненно	+	+	+	+	+

(РЕАБИЛИТАЦИЯ)

Реабилитационные мероприятия	Название медицинской услуги	СВП/СП	МПЦП	Минимальное количество мероприятий	Срок реабилитации
Консультация специалистов (врачей)	1. Медсестра	+		Определяется специалистом по показаниям	Если больной перенес ОКС, ЧКВ и АКШ, реабилитацию следует проводить в течение 2 мес.
	2. Семейный врач	+			
	3. Кардиолог		+		
	4. Терапевт		+		
	5. Диетолог		+		
	6. Физиотерапевт		+		
	7. Медицинский психолог		+		
Примечание: Пациентов со стабильной стенокардией I–II ФК без опасных нарушений сердечного ритма и проводимости можно направлять в местные кардиологические санатории, бальнеологические и климатические курорты для проведения комплексной программы реабилитации. Пациентам со стенокардией III–IV ФК и тяжелыми сопутствующими заболеваниями санаторное лечение не рекомендуется.					
Лабораторные исследования	1. Общий анализ крови	+	+	После осмотра врача назначается по показаниям	
	2. Общий анализ мочи	+	+		
	3. АЛТ, АСТ, билирубин	+	+		
	4. Липидный спектр	+	+		
	5. Сахар крови	+	+		
	6. Креатинин	+	+		
Примечание: рекомендуется анализировать исследования крови для оценки эффективности и безопасности препаратов.					
Инструментальные исследования	1. ЭКГ	+	+	После осмотра врача назначается по показаниям	
	2. ЭхоКС		+		
	3. Рентгенография грудной клетки		+		
	4. ХМЭКГ		+		
	5. ВЭМ или тредмил-тест		+		
Примечание: ВЭМ или тредмил-тест рекомендуются для оценки толерантности к физической нагрузке, прогноза и/или эффективности лекарственной терапии.					
Лечебные мероприятия (медикаментозное лечение)		СВП/СП	МПЦП	Средняя суточная доза	Курсовая доза
Название (международное непатентованное)	Применение и дозировка лекарственного средства				

лекарственного средства					
1. Ацетилсалициловая кислота	**75-150 мг 1 раз в день**	**+**	**+**	**75-150 мг**	**умрбод**
2. Клопидогрел	**75 мг 1 раз в день**	**+**	**+**	**75 мг**	**1 йил**
3. Статины: **- Розувастатин** **Аторвастатин**	**- Розувастатин 5-40 мг 1 раз в день** **- Аторвастатин 10-80 мг 1 раз в день**	**+**	**+**	**- Розувастатин 5-40 мг** **- Аторвастатин 10-80 мг**	**пожизненно**
4. Блокаторы РААС: **А) иАПФ:** **- Эналаприл** **- Рамиприл** **- Периндоприл** **Б) БРА (сартанлар):** **- Валсартан** **- Лозартан** **- Кандесартан** **- Телмисартан** **- Азилсартан** **- Олмесартан**	**иАПФ:** **- Эналаприл 2,5-20 мг 2 раз в день** **- Рамиприл 2,5-10 мг 1 раз в день** **- Периндоприл эрбумин 2-8 мг 1 раз в день** **- Периндопил аргинин 2,5-10 мг 1 раз в день** **БРА:** **- Валсартан – 40-320 мг 2 раз в день** **- Лозартан 25-100 мг 1 раз в деь** **- Кандесартан 4-32 мг 1 раз в день** **- Телмисартан 10-80 мг 1 раз в день** **- Азилсартан 20-80 мг 1 раз в день** **- Олмесартан 10-40 мг 1 раз в день**	**+**	**+**	**иАПФ:** **- Эналаприл 2,5-20 мг** **- Рамиприл 2,5-10 мг** **- Периндоприл эрбумин 2-8 мг** **- Периндопил аргинин 2,5-10 мг** **БРА:** **- Валсартан – 40-320 мг** **- Лозартан 25-100 мг** **- Кандесартан 4-32 мг** **- Телмисартан 10-80 мг** **- Азилсартан 20-80 мг** **- Олмесартан 10-40 мг**	**пожизненно**
5. Коротко действующие нитраты: **- Нитроглицерин**	**Нитроглицерин 0,1-1,2 мг использовать в виде таблеток или спрея сублингвально только при приступах стенокардии**	**+**	**+**	**0,1-1,2 мг**	**Только при приступах стенокардии**
6. Бета-блокаторы: **- Бисопролол** **- Метопролол**	**- Бисопролол 2,5-10 мг 1 раз в день** **- Метопролол сукцинат 25-100 мг 1 раз в день**	**+**	**+**	**- Бисопролол 2,5-10 мг** **- Метопролол**	**пожизненно**

- Небивалол - Карведилол	- Небивалол 2,5-10 мг 1 раз в день - Карведилол 3,125-25 мг кунлик дозаси 2-3 раза в день			сукцинат 25-100 мг - Небивалол 2,5-10 мг - Карведилол 3,125-25 мг	
7. Дегидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов: - Амлодипин - Лерканидипин - длительно действующий нифедипин	- Амлодипин 2,5-10 мг 1 раз в день - Лерканидипин 5-20 мг 1 раз в день - Нифедипин ретард 30-60 мг 1 раз в день	+	+	- Амлодипин 2,5-10 мг - Лерканидипин 5-20 мг - Нифедипин ретард 30-60 мг	пожизнено
Примечание: Состав лекарственной терапии может меняться в зависимости от тяжести заболевания и наличия сопутствующих заболеваний.					

(ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ)

Мероприятия по диспансеризации	Название медицинских услуг	СВП/СП	МПЦП	Минимальное количество мероприятий	Срок диспансерного наблюдения
Консультация специалистов (врачей)	1. Медсестра	+	+	- для I-II ФС и других форм ХИБС: 2 раза в год - для III-IV ФК 4 раза в год	пожизненно
	2. Семейный врач				
	3. Кардиолог		+		
	4. Невролог		+	По показаниям	
	5. Эндокринолог		+		
	6. Нефролог		+		
	7. Офтальмолог		+		
Примечание: Повторные осмотры рекомендуются для контроля достижения целевого АД, Хс-ЛПНП и титрации дозы антиишемической терапии. При IV ФК количество осмотров может больше.					
Лабораторные исследования	1. Общий анализ крови	+	+	- для I-II ФС и других форм ХИБС: 2 раза в год - для III-IV ФК 4 раза в год	
	2. Общий анализ мочи	+	+		
	3. Сахар крови	+	+		
	4. Креатинин	+	+		
	5. Липидный спектр	+	+		

	6. АЛТ, АСТ, общая КФК	+	+		
	7. Коагулограмма	+	+		
	8. Тропонин		+	По показаниям	
	9. МВ-КФК		+		
	10. ТТГ		+		
	11. МНУП		+		
	12. Электролиты крови: калий, натрий, кальций		+		
	13. Общий белок		+		
	14. Гомоцистеин		+		
Примечание: Во время периодических осмотров могут быть назначены дополнительные лабораторые исследования.					
Инструментальные исследования	1. ЭКГ	+	+	- для I-II ФС и других форм ХИБС: 2 раза в год - для III-IV ФК 4 раза в год	
	2. ЭХОКГ		+	По показаниям	
	3. ХМЭКГ		+		
	4. Рентгеноскопия грудной клетки		+		
	5. УЗИ брахиоцефальных артерий		+		
	6. УЗИ внутренних органов		+		
	7. ВЭМ или тредмил-тест		+		
Примечание: Во время периодических осмотров могут быть назначены дополнительные инструментальные исследования.					